RG Legg barn

Endring siden forrige versjon
Forlenget gyldighet til 10.12.2027 uten endringer i dokumentet.

Sammenligningsbilde
Kun aktuell side avbildes. Kontralateral side kun på forespørsel fra henviser etter konferering med radiolog.

Indikasjon	Smerteutredning, Skade, kontroll	*Front AP, Side*

FRONT AP		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Pasienten liggende rett på ryggen med utstrakt bein. Beinet roteres 3-5° innover for korrekt AP, slik at laterale og mediale femurepicondyl er like langt fra detektor	
SENTRERING	I tibias midtlinje, midt mellom ankel- og kneledd	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Eminentia tibialis midt i fossa intercondylaris femoris. Tibia og fibula overprojiseres noe både proksimalt og distalt. Både ankel- og kneledd inkluderes.	
KOMMENTAR	Tilstreb å få begge ledd på samme bilde. Dersom man allikevel må ta to bilder må leggen ha samme leie på begge bildene.	
SIDE		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Pasienten liggende på siden med aktuell side mot detektor. Beinet roteres i rett side, slik at laterale og mediale femurepicondyl ligger rett over hverandre, og patellas coronale plan er vinkelrett på detektor. Kneet flekteres omtrent 45° for å lettere få rett sidebilde.	
SENTRERING	Midt mellom kne- og ankelledd, midt på leggen	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Laterale og mediale epicondyls posteriore kant overprojiseres. Tuberositas tibia fremstilles i profil. Deler av caput fibula overprojiseres av tibia, og distale fibula overprojiseres av tibias bakre halvdel. Både ankel- og kneledd inkluderes.	

KOMMENTAR	Tilstreb å få begge ledd på samme bilde. Dersom man allikevel må ta to bilder må leggen ha samme leie på begge bildene.

Referanser

Vedlegg

Slutt på Sjekkliste